

Hematuria y retención urinaria aguda

1. Introducción y relevancia clínica

Hematuria

La **hematuria** se define como la **presencia anormal de eritrocitos en la orina**, y puede ser **macroscópica (visible)** o **microscópica (solo detectada al microscopio)**.

Es un **síntoma, no una enfermedad**, y puede indicar desde una **infección urinaria banal** hasta un **carcinoma urotelial o renal**.

- En hombres mayores de 50 años, la hematuria debe considerarse **cáncer vesical o prostático hasta demostrar lo contrario**.
 - En pacientes jóvenes, las causas más comunes son **litiasis, infección o ejercicio intenso**.
-

Retención urinaria aguda (RUA)

La **RUA** es la **incapacidad súbita e involuntaria de orinar**, acompañada de **distensión vesical dolorosa**, y constituye una **urgencia urológica**.

El diagnóstico es clínico y su manejo inmediato es **el drenaje vesical mediante sonda Foley**, identificando luego la causa subyacente.

- ☐ En el **EUNACOM**, este tema aparece en:
 - Interpretación de **hematuria macroscópica** (litiasis, cáncer, glomerulonefritis).
 - **Enfoque diagnóstico** (tira reactiva, urocultivo, TAC, cistoscopia).
 - **Manejo de la RUA** y sus causas más frecuentes (HPB, medicamentos, obstrucción).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Hematuria

Los eritrocitos pueden aparecer en la orina por:

1. **Lesión glomerular** (filtración alterada).
2. **Lesión no glomerular** (en cualquier parte del tracto urinario).

Según el nivel anatómico:

Nivel	Mecanismo	Ejemplos
Glomerular	Daño a la barrera de filtración (glomerulonefritis)	Glomerulonefritis postestreptocócica, nefropatía por IgA
Renal (no glomerular)	Necrosis tubular, infarto renal, tumor	Pielonefritis, cáncer renal
Ureteral / vesical / prostático / uretral	Lesión mecánica o inflamatoria	Litiasis, tumor vesical, trauma, prostatitis

2.2. Retención urinaria aguda

La micción depende de la coordinación entre el **detrusor vesical** y el **esfínter uretral**.

Cualquier falla mecánica u obstructiva puede impedir el vaciamiento.

Causas principales

1. Obstructivas (más frecuentes)

- HPB (70–80% en varones mayores).
- Estenosis uretral.
- Tumores prostáticos o vesicales.
- Cálculos enclavados.

2. Neurológicas

- Lesión medular, esclerosis múltiple, neuropatía diabética.

3. Farmacológicas

- Anticolinérgicos, opioides, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos.

4. Infecciosas / inflamatorias

- Prostatitis aguda, cistitis grave, absceso prostático.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Hematuria

A. Hematuria macroscópica

- Orina roja o color té oscuro.
- Sin coágulos → origen glomerular.
- Con coágulos → origen urológico (postglomerular).
- Puede acompañarse de:
 - Dolor tipo cólico → litiasis.
 - Disuria y fiebre → infección urinaria.
 - Masa palpable → tumor renal.

B. Hematuria microscópica

- 3 eritrocitos por campo en sedimento urinario.
- Asintomática o detectada en control.
- Requiere estudio para descartar malignidad en >40 años.

3.2. Retención urinaria aguda

- **Dolor hipogástrico intenso** con urgencia miccional infructuosa.

- **Masa vesical palpable y dolorosa.**
- Paciente inquieto, ansioso.
- Si crónica, puede presentarse con:
 - Goteo terminal, disminución del chorro, orina residual elevada.
 - Insuficiencia renal post-renal (elevación de creatinina).

3.3. Diagnóstico diferencial

Síntoma principal	Diagnóstico diferencial	Características
Hematuria sin dolor	Cáncer vesical o renal	En mayores de 50 años, fumadores
Hematuria + dolor tipo cólico	Litiasis urinaria	Irradiación a genitales
Hematuria + fiebre + disuria	Pielonefritis, prostatitis	Síndrome febril infeccioso
Hematuria + cilindros eritrocitarios	Glomerulonefritis	Proteinuria y creatinina elevada
Retención dolorosa	HPB, cálculo o tumor	Distensión vesical aguda
Retención sin dolor	Neuropatía diabética, fármacos	Residuo vesical elevado

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. En hematuria

A. Laboratorio

- **EGO:** confirma hematuria, descarta infección.
 - Eritrocitos dismórficos → origen glomerular.
 - Eritrocitos normales → origen urológico.
- **Proteinuria significativa (>500 mg/día)** → glomerular.
- **Urocultivo:** descarta ITU.
- **Creatinina y BUN:** evalúa función renal.
- **Citología urinaria:** útil para sospecha de carcinoma urotelial.

B. Imágenes

- **Ecografía renal y vesical:** primer examen.
- **TAC urográfico (sin y con contraste):** gold standard en hematuria no explicada.
- **Cistoscopia:** obligatoria en toda hematuria macroscópica no infecciosa, especialmente >40 años.

4.2. En retención urinaria aguda

- **Cateterismo diagnóstico:** si sale >500 mL de orina, confirma RUA.
- **Ecografía vesical postmiccional:** evalúa residuo urinario (>150 mL es anormal).
- **Creatinina y electrolitos:** descartar IRA obstructiva.
- **TAC o ecografía prostática:** si se sospecha obstrucción por tumor o litiasis.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL Chile 2022 y EAU 2023)

5.1. Hematuria

A. Medidas generales

- Reposo relativo e hidratación adecuada.
- Suspender anticoagulantes o antiagregantes si es posible.
- Control de diuresis y presión arterial.

B. Tratamiento etiológico

Causa	Tratamiento
ITU	Antibióticos dirigidos (ceftriaxona, ciprofloxacino, nitrofurantoína según germen)
Litiasis urinaria	Analgesia, hidratación, eventual LEOC
HPB o cáncer de próstata	Manejo médico urológico o quirúrgico
Tumor vesical	Cistoscopia + resección transuretral
Glomerulonefritis	Tratamiento nefrológico específico (corticoides, inmunosupresores)
Trauma renal / vesical	Manejo quirúrgico o conservador según grado

C. Hematuria severa con coágulos (urgencia)

- Irrigación vesical continua con suero fisiológico (3 vías).
 - Retirar coágulos para evitar obstrucción.
 - Consultar urología urgente si sangrado persistente.
-

5.2. Retención urinaria aguda

A. Manejo inicial

1. Aliviar la distensión vesical:

- Colocar **sonda Foley n.º 16–18** con lubricante anestésico (lidocaína gel).
- Si hay trauma uretral sospechado (sangre en meato o antecedente de caída astride): **no sondar**, realizar **uretrografía retrógrada**.

2. Registrar volumen drenado:

- Si >1000 mL, mantener drenaje controlado para evitar hematuria postdescompresiva.

3. Control del dolor y ansiedad.

4. Identificar y tratar la causa.

B. Tratamiento específico

Causa	Tratamiento
HPB	Alfa-bloqueadores (tamsulosina 0,4 mg/día) ± finasteride. Evaluar cirugía (RTUP).
Cálculo uretral / vesical	Extracción endoscópica.
Prostatitis aguda	Antibióticos EV (ceftriaxona o ciprofloxacino) y drenaje diferido.
Fármacos anticolinérgicos u opioides	Suspensión o antídoto específico.
Lesión neurológica	Cateterismo intermitente o sonda permanente.

C. Indicaciones de derivación a urología

- Hematuria persistente o recidivante.
 - Retención con sospecha de tumor, litiasis o trauma.
 - Fracaso del cateterismo.
 - Obstrucción bilateral o IRA postrenal.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Manejo
IRA postrenal	Obstrucción prolongada	Drenaje y control de electrolitos
Infección urinaria / prostatitis	Sonda prolongada o estasis	Antibióticos y retiro precoz
Hematuria postdescompresiva	Reperusión rápida de vejiga distendida	Irrigación y observación
Reestenosis o recurrencia	Causa no tratada (HPB, tumor)	Seguimiento urológico

Pronóstico:

Generalmente favorable si se identifica la causa y se maneja precozmente.

Las **retenciones por HPB** se resuelven con buena respuesta al tratamiento médico-quirúrgico.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Hematuria macroscópica = estudio obligatorio, no atribuir a “ITU simple”.**
 2. **Coágulos en orina → origen postglomerular.**
 3. **Cistoscopia** es obligatoria en hematuria sin causa evidente en mayores de 40 años.
 4. **RUA por HPB = causa más frecuente en hombres mayores.**
 5. **Nunca forzar el sondaje si hay sospecha de trauma uretral.**
 6. **Tamsulosina** favorece la micción post-retención.
 7. **Irrigación vesical** si hay coágulos obstructivos.
-



Errores comunes

- No estudiar una hematuria aislada en pacientes mayores.
 - Asumir que toda hematuria es infecciosa sin urocultivo.
 - Dejar a un paciente con retención sin drenaje inmediato.
 - Sondar sin descartar lesión uretral.
 - No corregir causa obstructiva post-retención (riesgo de recidiva).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hematuria = síntoma que siempre requiere estudio estructural (eco, TAC, cistoscopia).**
2. **Coágulos → origen urológico; proteinuria → origen glomerular.**
3. **RUA más comúnmente por HPB; manejo inicial = sonda Foley.**

4. **Nunca forzar el sondaje ante sospecha de trauma uretral.**
5. **Hematuria severa → irrigación vesical + urología.**
6. **Drenar primero, diagnosticar después.**
7. **Pronóstico excelente si se trata precozmente.**